

**UNIVERSITE DE DOUALA
ENSET DE DOUALA**

DEPARTEMENT DES SCIENCES DE L'EDUCATION

Niveau 5 : TRONC COMMUN

**PSYCHOLOGIE DU
DEVELOPPEMENT ET DES
APPRENTISSAGES**

Enseignants :

Dr NOUMBI NOUWOU Georges, Chargé de Cours

M. OHANDJA NDONGO Jonathan, Chargé de TD

M. MVONDO Théodore, Chargé de TD

Contacts respectifs : +237 670183563/ 691510622

SEMESTRE I

[2026-2025]

PREMIERE PARTIE : PSYCHOLOGIE DU DEVELOPPEMENT

INTRODUCTION GENERALE : QUELQUES BRANCHES DE LA PSYCHOLOGIE

CHAPITRE 1 : BASES ET FACTEURS DU DEVELOPPEMENT

A – Les bases du développement

- 1) – Equipement neurologique de base
- 2) – Les modalités sensorielles

B – Les facteurs du développement

- 1) – Les facteurs biologiques
- 2) – Les facteurs sociaux
- 3) – L'activité du sujet

CHAPITRE 2 : LES PRINCIPALES APPROCHES THEORIQUES DU DEVELOPPEMENT

- 1) L'approche psychanalytique
- 2) L'approche behavioriste et néobehavioriste
- 3) L'approche cognitiviste
- 4) L'approche humaniste
- 5) L'approche écologique
- 6) L'approche évolutionniste

SECTION 3 : LES TYPES DE DEVELOPPEMENT

A – Le développement intellectuel

B – Le développement psychoaffectif

C – Le développement socio-émotionnel des nourrissons aux carences affectives

D – Le développement des relations à l'adolescence

DEUXIEME PARTIE : PSYCHOLOGIE DES APPRENTISSAGES

Introduction générale : Les postulants behavioristes et la théorie de l'apprentissage

A- Les conceptions de l'enseignement-apprentissage

- 1- Le modèle de l'empreinte
- 2- Le modèle behavioriste
- 3- Le modèle cognitiviste
- 4- Le modèle constructiviste
- 5- Le modèle socio-constructiviste
- 6- Le modèle connexionniste

B- Typologie des apprentissages

- 1- Les apprentissages non associatifs
- 2- Les apprentissages associatifs
- 3- Les apprentissages sociaux

INTRODUCTION GENERALE

« *On ne naît pas homme, on le devient.* »

ÉRASME (1469–1536)

La citation d'Érasme mise en exergue ci-dessus se comprend facilement et procure immédiatement un sentiment de vérité, suggérant le long cheminement psychologique qui va de la naissance à l'âge adulte, et l'importance de l'éducation dans ce développement. Mais si nous disons : « *on ne devient pas homme sans naître humain* », le caractère nécessairement vrai de cette seconde proposition est également une évidence. On conçoit alors aisément l'objectif de ce cours : présenter des éléments de connaissance psychologique sur l'évolution de l'enfant et de l'adolescent, de manière à illustrer l'absence de contradiction entre les deux propositions indiquées et à fournir les éléments d'information et d'analyse qui permettent de les relier. Nous nous intéressons aux processus développementaux et ceux maturationnels.

L'ensemble de ces processus maturatifs rend compte de la *néoténie* du nourrisson humain : par néoténie on entend en effet, la prématurité physiologique du petit humain par rapport à la plupart des nouveau-nés des autres espèces animales. Le nouveau-né humain vient au monde avec un équipement insuffisant pour s'adapter activement à l'environnement. Ce rôle est dévolu à l'entourage du bébé pendant les premières années. Cette donnée fondamentale rend compte en partie l'importance de la socialisation chez l'être humain. À côté des concepts classiques de *phylogenèse* (qui caractérise l'évolution des espèces), et *d'ontogenèse* (qui caractérise le développement de l'individu à partir de son patrimoine génétique), le concept plus récent *d'épigenèse* rend compte de cette néoténie.

On appelle *épigenèse* toute l'organisation progressive somatique ou comportementale de l'individu qui est une construction dépendant à la fois du programme génétique et des matériaux et informations mis à sa disposition par l'environnement. Ce concept d'épigenèse rend compte des difficultés à vouloir de manière trop caricaturale séparer l'équipement génétique inné et l'apport environnemental acquis. Dans une espèce particulière, la place de l'épigenèse est d'autant plus grande que la néoténie est importante : ceci est bien évidemment le cas du bébé humain.

En effet, le développement humain est un processus dynamique et continu qui perdure tout au long de la vie. Tout en maintenant une certaine continuité, chaque dimension de la personne, qu'elle soit physique, cognitive, affective ou sociale, subit de profonds changements, sous les influences respectives et souvent combinées de l'hérédité et de l'environnement. Chacune d'elles se développe en interaction avec les autres, faisant alors du développement un processus global. Au fil du temps, différents courants de pensée se sont intéressés au développement humain, notamment les approches psychanalytique, béhavioriste, cognitiviste, humaniste et écologique. Toutefois, si aucune d'entre elles ne suffit à expliquer en totalité le développement et sa complexité, chacune propose un angle particulier essentiel à la compréhension des processus qui le composent.

CHAPITRE 1 : BASES ET FACTEURS DU DEVELOPPEMENT

Dès la naissance, le nouveau-né est amené à organiser des échanges avec le milieu (physique et humain) qui l'environne. Cette organisation s'appuie sur un état de base qui constitue le point de départ du développement de l'enfant. Deux secteurs sont particulièrement importants à citer :

- *l'équipement neurologique de base*
- *les modalités sensorielles.*

C'est sur ces premiers points d'appui que vont jouer les divers facteurs du développement. Ils conditionnent et orientent le développement ultérieur et sont génétiquement déterminés. Ainsi que le faisait remarquer *H. Wallon*, le bébé est biologiquement orienté vers le milieu humain. C'est ce milieu qui lui permet de survivre puisqu'il est incapable de subvenir par lui-même à ses propres besoins (théorie de la foetalisation).

Le corollaire de cette impéritie (imperfection ou une immaturité) est le fait que dès la naissance, le bébé dispose de la capacité d'exprimer, d'indiquer quels sont ses besoins et d'entrer en relation avec le milieu humain.

A – BASES DU DEVELOPPEMENT

1) – L'équipement neurologique de base

Il se manifeste au travers des réflexes archaïques, du tonus et de la posture, du tempérament et du niveau de vigilance. Ces diverses composantes constituent la base neurophysiologique de l'individu.

a. – Les réflexes archaïques

Le bébé possède dès la naissance des montages réflexes appelés à disparaître dans la suite de son développement.

Les réflexes archaïques et leur évolution occupent un rôle neurologique dans l'évaluation de la normalité neurologique des nourrissons. On recherchera systématiquement la présence de certains d'entre eux (*le réflexe de Moro, le réflexe de la marche automatique à la naissance ou dans les premières semaines de la vie*). On vérifiera leur disparition plus tard. Leur absence ou retard de disparition renseigne sur d'éventuelles lésions ou immaturités du système nerveux central. Il existe une dizaine de réflexes répertoriés sous **deux catégories** :

➤ Les réflexes dont le rôle n'est pas déterminé dans le développement ultérieur

- **Le réflexe de Moro** : C'est le plus typique de cette période de développement. L'enfant ici est couché sur le dos, sur un coussin. Si on frappe violemment sur le coussin, les bras de l'enfant s'écartent symétriquement, les doigts de chacune de ses mains aussi s'écartent. Les bras se rejoignent ensuite en arc de cercle. Ce réflexe apparaît nettement pendant les huit premières semaines après la naissance mais s'il persiste après le septième et le huitième mois, c'est le signe d'une pathologie.

Le réflexe de Moro est présent dès la naissance et disparaît normalement vers 4, 5 mois. Il existe diverses techniques pour le mettre en évidence. En fait, il faut imprimer un mouvement brusque à la tête du nouveau-né. Le réflexe consiste en l'ouverture, l'extension et la fermeture des bras.

- **Le réflexe de redressement** : Si on exerce une pression sur la plante des pieds de l'enfant, celui-ci aura tendance à étendre les divers segments de ses membres inférieurs c'est-

à-dire à se redresser pour adopter une position verticale. Ce réflexe s'observe à la naissance jusqu'à deux, trois mois.

- **Le réflexe de la marche automatique** : Ici on tient l'enfant par les aisselles les plantes de ses pieds étant sur une surface solide. Lorsqu'on penche l'enfant en avant on obtient des mouvements alternés d'extension et flexion des membres inférieurs. Ce réflexe est absent chez les grands prématurés (six – sept mois). Il apparaît au huitième d'âge fœtal. Son absence chez un enfant de six semaines est considérée comme pathologique.

Présent dès la naissance, il disparaît vers 4, 5 mois. Pour le mettre en évidence, on tient le nouveau-né sous les aisselles, on l'incline légèrement vers l'avant tout en maintenant ses plantes des pieds au sol. Le réflexe consiste en un déroulement de la cuisse, de la jambe, du pied, alternativement d'une jambe puis de l'autre. Ce réflexe n'existe pas chez les grands prématurés. L'absence du réflexe chez un nouveau-né à terme peut être pathologique ; la permanence du réflexe au-delà d'un certain âge aussi.

- **Le réflexe d'incurvation du tronc** : On stimule la peau du dos vers la colonne vertébrale de l'enfant. Ce dernier incurve le tronc et la concavité épouse la zone stimulée. C'est un réflexe qui est observé à la naissance mais qui disparaît au cinquième, sixième mois.

- **Le réflexe d'enjambement** : L'enfant ici est soutenu par les aisselles en position verticale. On l'amène à affleurer ou à toucher le bord d'une table ou d'un lit. Il se produit une élévation du pied qui tend à se placer sur le dessus de la table. Ce réflexe est obtenu dès le dixième jour.

- **Le réflexe d'allongement croisé** : Si on stimule la plante de pied d'un enfant, l'autre pied ébauche d'abord un mouvement de replis, de flexion puis ensuite le pied se détend vers le point stimulé de l'autre pied. L'absence de ce réflexe qui apparaît dès la naissance est pathologique.

- **Le grasping reflexe** : Il se décompose en deux parties : Le réflexe de préhension où l'enfant va vouloir se suspendre à nos doigts. Le réflexe d'agrippement : si l'on chatouille la paume de la main de l'enfant, il referme sa main. Si l'on essaie de le tracter, il renforce sa prise. Ce réflexe va disparaître vers un an. Lorsqu'un nouveau – né tient quelque chose dans sa main, il ne sait pas comment la lâcher, il suffit alors d'appuyer sur le dos de main.

On l'obtient en stimulant la paume de la main du bébé... On assiste à une fermeture des doigts (*réflexe automatique des extenseurs*). Ce réflexe persiste jusqu'à la fin de la première année. Son absence unilatérale ou bilatérale est un signe d'alarme ; sa persistance au-delà du premier anniversaire aussi.

➤ **Les réflexes s'intégrant, se transformant dans des formes de comportements plus complexes et même volontaires :**

- **Le réflexe de foussement ou le rooting reflexe** : Il se compose de deux réflexes. Le premier : Si on stimule la région péribuccale il se produit chez l'enfant une réaction de la tête qui se tourne de plusieurs fois de suite et à la fin, il se produit un mouvement de succion. Présent dès la naissance, ce réflexe disparaît dès le troisième mois. Le deuxième : Si on stimule directement les lèvres de l'enfant, les lèvres et la langue se dirigent vers l'objet stimulateur et les lèvres se referment sur l'objet et la succion se produit instantanément.

- **Le réflexe de refoulement de la langue** : L'enfant rejette l'aliment solide ou le petit objet avec sa langue.

- **Le réflexe de succion et de déglutition** : Il va permettre à l'enfant d'avaler sa nourriture. Il se produit lorsqu'on introduit un aliment dans la bouche de l'enfant et lorsque celui-ci entre en contact avec le palais, il y a alors un mouvement de la langue et de la mâchoire inférieure. Ce réflexe ne disparaît pas mais il devient plus volontaire et plus contrôlable par l'enfant.

- **Le réflexe de landau** : Si on pose un enfant sur la main de l'adulte par le ventre, celui-ci va lever la tête et incurver la colonne vertébrale. Le mouvement va ensuite se compléter par une extension des cuisses de l'enfant. Ce mouvement va se perfectionner au fur et à mesure de la croissance de l'enfant.

- **Le réflexe des points cardinaux** : L'enfant va s'orienter en direction de la stimulation.

b. – Le tonus et la posture

Le tonus est l'état de tension des muscles. Le tonus est responsable des mouvements et de la posture. Cette dernière est une mise en forme du corps dans des attitudes permises par l'immobilisation des segments dans des positions déterminées. Au début de sa vie, le nouveau-né n'a guère de prise sur son activité posturale qui est d'ordre réflexe. Les répartitions du tonus dépendent de la maturation neurologique.

c. – Le tempérament

C'est la façon de rendre compte de ce qui, dans le comportement développé par les bébés, relève de l'équipement neurophysiologique inné. Plusieurs typologies du tempérament ont été proposées.

➤ **Les enfants faciles :**

Ils ont un rythme facile à établir, une réaction moyenne à la nouveauté et s'y adaptent facilement. Leurs émotions sont d'intensité modérée et plus souvent à tonalité positive.

➤ **Les enfants difficiles :**

Au contraire, leur rythme est lent à établir. Ils ont de fortes réactions à la nouveauté, et s'y adaptent mal. Leurs émotions sont vives à tonalité négative. Leur adaptation au changement est difficile.

➤ **Les enfants lents à réchauffer :**

Leurs réactions sont de faible intensité, leurs activités faibles, leur adaptation lente à la nouveauté.

2) – Les modalités sensorielles

Elles sont toutes fonctionnelles dès la naissance et certaines d'entre elles sont in utero. Elles continuent de se développer par la suite sous la double influence de la maturation et de l'exercice (*globalement, il s'agit des 5 sens*).

a. – l'olfaction

Plusieurs axes de recherches montrent que dès les premiers jours de la vie, le bébé est capable de reconnaître l'odeur de sa mère. *Mc Farlane (1983)* montre que dès le sixième jour de la vie, les bébés orientent plus fréquemment leurs têtes vers une compresse imprégnée de l'odeur du sein de leur mère, que vers une compresse imprégnée de l'odeur d'une autre mère allaitante. En général, l'odeur de la mère chez les enfants de 2/3 ans les apaise et les sécurise.

b. – la sensibilité gustative

Cette modalité fut longtemps méconnue. Il s'avère pourtant qu'elle joue un rôle important dans le répertoire des moyens expressifs de l'enfant. *M. Shiva (1985)* a pu démontrer que dès la naissance, le réflexe gusto – facial (*RGF*) est associé à chacune des saveurs suivantes :

- **saveur sucrée** : Visage détendu, ébauche de sourire, tétée ou clappement de la langue.
- **acide** : Yeux plissés, froncement de la racine du nez, Protusion des lèvres.
- **amer** : Bouche ouverte, plissement du front, mouvements comme pour vomir.
- **Salé** : Froncement du nez, plissement des lèvres, mouvement des joues et de la bouche.

c. – La sensibilité tactile

Dans la perspective de *D. W. Winnicott*, l'enfant sera sensible *au handling et au holding*

- **le handling** : Désigne la manière dont l'enfant est manipulé
- **le holding** : La façon dont il est porté.

De la façon dont la mère le manipule et le porte, il apparaît que celle-ci traduit ses dispositions, sa sensibilité à l'égard du bébé.

d. – L'audition

Dès la naissance, les nouveau-nés sont sensibles à la stimulation auditive ; ils y répondent fréquemment par une réaction de l'orientation vers la direction de la source sonore. Elle est un des moyens à utiliser pour augmenter le niveau de vigilance de l'enfant.

e. – La vision

Cette modalité est fonctionnelle dès la naissance ; bien que le nouveau-né ne maîtrise pas totalement certaines de ses fonctions par manque de maturation. L'amélioration des dispositions d'analyse de l'activité visuelle précoce montre qu'en fait, le bébé dispose d'une capacité égale à celle de l'adulte en ce qui concerne l'accommodation.

Au cours de la première année, certaines compétences visuelles vont se développer : élargissement du champ individuel, capture rapide d'un stimulus pour l'amener dans la région fovéale, poursuites oculaires rapides et complexes.

Ce développement dû à la maturation et à l'exercice, favorise l'exploration du monde et des objets, et la complexité des échanges avec autrui.

B – LES FACTEURS DU DEVELOPPEMENT

1) – Les facteurs biologiques

Les influences internes qui s'exercent sur le développement proviennent de l'hérédité. L'hérédité individuelle est définie comme l'ensemble des traits génétiques hérités des parents, alors que les traits hérités de l'espèce à laquelle nous appartenons constituent l'hérédité spécifique. Parmi les facteurs biologiques, le rôle des hormones et celui de la maturation sont déterminants.

Ainsi, la maturation désigne les modifications neurophysiologiques et biochimiques qui se produisent dans l'organisme au cours du développement. De nombreux changements, surtout durant l'enfance et l'adolescence, sont liés à la maturation du corps, plus particulièrement à celle du cerveau. A la naissance, le système nerveux humain est très immature. L'être humain naît avec *14 000 000 000 de cellules* environ. Celles-ci ne sont pas opérationnelles à la naissance, il faut attendre que s'effectue progressivement la myélinisation (un processus au

cours duquel les cellules présentes dans le cerveau sont recouvertes par une substance de couleur blanche ou grisâtre appelée *Myéline* qui va permettre l'interconnexion des cellules).

La myélinisation va se poursuivre jusqu'à l'adolescence selon deux axes :

- *l'axe céphalo – caudal*
- *et l'axe primo – distal.*

In fine, la croissance physique est déterminée par des facteurs héréditaires (*gènes*).

2) – Les facteurs sociaux

On situe dans cette catégorie l'ensemble des apports que le milieu fournit à l'enfant. Les influences du milieu proviennent du contact avec le monde extérieur. Dès la fécondation, l'embryon, puis le fœtus, peut subir les influences du milieu prénatal. Toutefois, c'est surtout à partir de la naissance qu'une multitude de facteurs commencent à agir sur le développement du nourrisson : le type de famille dans laquelle il naît, le statut économique de celle-ci, la présence ou l'absence de frères et de sœurs, les relations avec les grands-parents, les caractéristiques de son voisinage, le type de société dans laquelle il évolue et sa culture d'appartenance sont parmi les facteurs les plus marquants.

On cite principalement le rôle fondamental joué par deux milieux : *la famille et l'école*.

a. la famille

C'est un système ouvert. C'est à son sein que s'effectuent les premières expériences émotionnelles et affectives, gratifiantes ou frustrantes qui se logeront dans les abysses psychiques pour servir d'infrastructures à l'édification de la personnalité (la personnalité est un processus dynamique qui se déroule au cours de l'ontogenèse par la mise en jeu de plusieurs facteurs : cognitif, affectif, moral, culturel, biologique).

b. l'école

C'est le deuxième cadre institutionnel qui, en principe, devrait se situer au prolongement du cadre de vie naturel. Ses missions essentielles sont l'éducation et l'instruction.

3)- L'activité du sujet

En général, c'est en fait en agissant que le bébé se construit sur les divers plans de l'organisation personnelle (*cognitif, affectif, moral, culturel, social...*). L'action propre est donc facteur du développement.

CHAPITRE 2 : LES APPROCHES THEORIQUES DU DEVELOPPEMENT

En psychologie du développement de l'enfant, différentes approches expliquent comment l'humain se développe. En effet, les scientifiques ont élaboré plusieurs théories ou approches qui rendent compte du développement des êtres humains et notamment celui de l'enfant. Ces diverses approches ont pour objectif principal d'expliquer le développement et de prédire quels comportements sont susceptibles d'apparaître sous certaines conditions. Au moins cinq approches théoriques permettent d'aborder l'étude du développement. Ce sont : les approches psychanalytiques, behavioriste, cognitiviste, humaniste et écologique.

1. L'APPROCHE PSYCHANALYTIQUE

C'est à Sigmund Freud que l'on doit l'approche psychanalytique. Cette approche stipule que le développement est marqué par l'action de forces inconscientes qui motivent le comportement humain, et que les événements qui se produisent durant l'enfance déterminent le développement de la personnalité adulte.

Deux pulsions dominent le comportement de façon inconsciente : la pulsion de vie (ou pulsion sexuelle) et la pulsion de mort (ou pulsion agressive). Selon Freud, la pulsion sexuelle et son assouvissement constituent des éléments essentiels du développement de la personnalité durant l'enfance. La libido, énergie psychique fondamentale et inconsciente, est le moteur de la pulsion de vie ; elle est investie de diverses manières à partir des relations que l'enfant développe avec son entourage. Cependant, les contraintes liées à la réalité extérieure et aux attentes sociales empêchent souvent la satisfaction de ces pulsions et génèrent alors des conflits intrapsychiques, la plupart du temps inconscients : la personne ne sait pas qu'elle vit ces conflits, alors que ces derniers influencent pourtant ses émotions, ses comportements et même sa santé physique et mentale. Ce n'est qu'avec l'aide d'une psychanalyse une forme de thérapie élaborée par Freud que ces conflits refoulés pourront sortir de l'inconscient et revenir à la mémoire du patient.

Selon Freud, la personnalité est une structure dynamique, c'est-à-dire qu'elle se développe avec le temps. Elle est composée de trois instances psychiques, le ça, le moi et le surmoi. Les nouveau-nés sont gouvernés par le ça, qui est la seule instance présente à la naissance. Source des pulsions de base et réservoir de l'énergie psychique, le ça est totalement inconscient, donc inaccessible directement, et il est amoral. Il ne supporte pas la tension et obéit au principe de plaisir, c'est-à-dire qu'il exige une satisfaction immédiate des besoins sans tenir compte de la réalité externe. Dans la théorie freudienne, la mère joue un rôle déterminant dans la satisfaction des besoins du très jeune enfant. Toutefois, elle ne peut les satisfaire parfaitement. Par exemple, lorsque le biberon est prêt, mais qu'il est trop chaud, l'enfant doit attendre et différer son plaisir : il connaît alors la frustration. L'enfant est ainsi amené peu à peu à découvrir que le monde extérieur existe, ce qui conduit au développement du Moi, la deuxième instance de la personnalité.

Le Moi obéit au principe de réalité. Il est rationnel et, en grande partie, conscient. Il joue un rôle de médiateur entre les exigences du ça et celles de la réalité extérieure ; c'est un peu l'« administrateur » de la personnalité. Selon Freud, la conscience de soi émane du moi. Plus tard

apparaît le surmoi, troisième instance de la personnalité, qui résulte de l'intériorisation des règles, des interdits et des principes moraux transmis par les parents et les autres représentants de la société. Le surmoi se forme au stade phallique, lorsque le complexe d'Œdipe est résolu et que l'enfant s'identifie à ses parents. En partie conscient, mais surtout inconscient, le surmoi obéit au principe de moralité. La plupart des conflits intrapsychiques naissent de l'opposition entre les exigences du ça et les interdits du surmoi. Lorsque les exigences du surmoi ne sont pas respectées, l'enfant peut se sentir coupable et développer de l'anxiété.

Selon Freud, une personnalité saine implique un équilibre relatif entre les trois instances de la personnalité. Lorsque le Moi ne parvient plus à jouer son rôle de régulateur entre le ça et le surmoi, le déséquilibre s'installe, engendrant de la tension et de l'anxiété. Le moi recourt alors à des mécanismes de défense inconscients, qui consistent à déformer la réalité ou à la nier pour soulager l'anxiété. Le refoulement est un exemple de mécanisme de défense qui vise, entre autres, à effacer du champ de la conscience des désirs ou des pulsions inacceptables ou à « oublier » un souvenir menaçant. Le déplacement est un autre mécanisme de défense du moi. Il est à l'œuvre lorsque vous donnez un coup de pied à votre chien après vous être disputé avec votre père. Selon Freud, ces mécanismes de défense sont normaux et tous les individus y ont recours, mais certains le font d'une manière trop rigide ou de façon trop répétitive, ce qui peut entraîner des troubles psychologiques.

2. LES APPROCHES BEHAVIORISTE ET NEOBEHAVIORISTE

À l'opposé de l'approche psychanalytique, elle nie les motivations inconscientes et considère le développement comme résultant de l'apprentissage, c'est-à-dire comme un ensemble de réactions à des stimuli et à des événements extérieurs. L'approche behavioriste met l'accent sur l'étude des comportements observables, mesurables et quantifiables. Selon les behavioristes, les changements de comportements dus à l'apprentissage et observés durant le développement découlent principalement de la façon dont un individu réagit aux stimuli agréables, douloureux ou menaçants qui viennent de son environnement. En effet, s'ils reconnaissent la limite imposée aux actions humaines par les mécanismes biologiques, les tenants de l'approche behavioriste accordent à l'environnement un rôle déterminant dans l'orientation du comportement : on dit qu'ils sont déterministes. Par conséquent, si l'on parvient à cerner toutes les influences exercées par l'environnement sur l'individu, on pourra prédire ses comportements, voire les modifier.

3. L'APPROCHE COGNITIVISTE

L'approche cognitive s'intéresse particulièrement aux processus cognitifs tels que la perception, la mémoire et la pensée, ainsi qu'aux comportements qui en résultent. Parmi les théoriciens qui s'inscrivent dans cette approche, Jean Piaget a eu une influence déterminante sur la compréhension de l'intelligence du jeune enfant. De son côté, Lev S. Vygotsky s'est également intéressé au développement cognitif des enfants, mais en situant les apprentissages dans leur contexte socio-culturel. Enfin, la théorie du traitement de l'information s'est surtout intéressée aux processus à l'œuvre dans la captation et la rétention de l'information.

4. L'APPROCHE HUMANISTE

L'approche humaniste s'appuie sur le postulat que chaque personne a la capacité de prendre sa vie en main et de veiller à son propre développement.

Carl Rogers (1902-1987) est l'un des fondateurs du courant humaniste. Selon Rogers, comme pour les autres humanistes, l'être humain est fondamentalement libre et peut donc orienter sa vie selon ses propres choix afin de se réaliser pleinement. Rogers s'intéresse essentiellement à la subjectivité des individus, c'est-à-dire à la façon dont ils perçoivent leurs expériences et les sentiments qui s'y rattachent. Au fur et à mesure que la personnalité se développe, le concept de soi se forme à partir de l'ensemble des perceptions qu'une personne a d'elle-même.

Cependant, l'être humain ne peut se réaliser sans entrer en relation avec les autres. Ainsi, selon Rogers, ces apprentissages sociaux auront une influence sur le développement et pourront faire obstacle à la congruence. En effet, l'enfant a besoin de considération positive de la part des personnes significatives qui l'entourent, c'est-à-dire d'être aimé, respecté et accepté. Pour que sa personnalité se développe de façon saine et congruente, cette considération positive doit être inconditionnelle : l'enfant doit être aimé pour lui-même et accepté en tant que personne, même si ses comportements ne sont pas toujours adéquats. Ainsi, lorsqu'un enfant se conduit mal, il est important, lorsqu'on le réprimande, de bien lui faire comprendre que c'est son comportement qui est en cause et non sa personne.

5. L'APPROCHE ECOLOGIQUE

Selon l'approche écologique, le développement de tout organisme biologique est le résultat des interactions continues entre cet organisme et son environnement.

Dans le cadre de l'approche écologique, le psychologue américain Urie Bronfenbrenner (1917-2005) a élaboré un modèle qui propose une grille d'analyse nouvelle et prometteuse du développement humain : le modèle bioécologique. Le modèle bioécologique de Bronfenbrenner décrit l'ensemble des facteurs (familiaux, géographiques, politiques, économiques, culturels, etc.) susceptibles d'influencer le développement d'une personne, et les interactions qui existent entre ces facteurs. Selon Bronfenbrenner, l'enfant se développe dans un environnement social d'une grande complexité : la famille est certes importante, mais elle n'est pas la seule composante qui l'influence.

Pour Bronfenbrenner, l'environnement dans lequel tout être humain se développe et évolue, constitue un système complexe divisé en quatre sous-systèmes : le microsystème, le mésosystème, l'exosystème et le macrosystème. Le microsystème désigne le milieu fréquenté régulièrement par une personne et dans lequel elle entretient des relations étroites avec d'autres individus. Une même personne évolue au sein de plusieurs microsystèmes : par exemple, la maison familiale, la garderie, l'école pour l'enfant ; la maison, le collège, le cercle d'amis pour l'adolescent ; la maison, le lieu de travail, le centre de loisirs pour l'adulte. Dans chacun de ces microsystèmes, l'individu entretient des relations personnelles avec son entourage et joue différents rôles ; on nourrit des attentes à son égard et il doit suivre certaines règles. Le même individu peut connaître des difficultés d'adaptation dans un microsystème particulier et très bien fonctionner dans un autre. De plus, ces divers microsystèmes peuvent différer d'un individu à l'autre. Ainsi, certains enfants seront élevés dans une famille aisée, alors que d'autres

vivront dans une famille défavorisée, certains auront des frères et sœurs, d'autres seront enfants uniques, certains verront souvent leurs grands-parents, d'autres pas.

Le mésosystème correspond, quant à lui, aux interactions qui existent entre les différents microsystèmes d'une personne : entre l'école ou la garderie et la famille pour l'enfant, ou encore entre la maison et le travail ou le travail et la communauté pour l'adulte. Cette dimension inclut également les réseaux de soutien social, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui composent l'entourage et qui offrent un ou plusieurs types de soutien.

En troisième lieu, l'exosystème désigne des instances (généralement des institutions) qui ne sont généralement pas fréquentées par la personne qui se développe, mais dont les décisions exercent une influence sur sa vie. C'est le cas, entre autres, des commissions scolaires, des conseils d'administration et des organismes gouvernementaux.

Enfin, le macrosystème représente le système le plus large, puisqu'il comprend les trois précédents. Il constitue une sorte de toile de fond et inclut les modèles culturels, les idéologies et les valeurs d'une société, d'une culture. Les systèmes économiques et politiques en font également partie.

Enfin, selon Bronfenbrenner, la personne n'est pas seulement le produit de son développement, elle agit également sur lui par l'entremise de ses caractéristiques physiques et psychologiques, de ses talents et de ses habiletés, de ses forces et de ses faiblesses.

6- L'APPROCHE EVOLUTIONNISTE

D'après ce modèle théorique, *Charles Darwin (1809-1882)* est le père fondateur de la psychologie du développement en référence à la publication des observations qu'il avait pu mener sur *son fils Doddy*. La perspective évolutionniste considère l'enfant comme l'objet d'étude et l'observation comme méthode privilégiée pour le comprendre. Cette approche insiste sur l'hérédité des différences individuelles.

CHAPITRE 3 : LES MODELES DE DEVELOPPEMENT

A – LE DEVELOPPEMENT COGNITIF

Piaget cherche à répondre à la question comment l'intelligence se développe-t-elle ?

D'après Piaget, le développement cognitif progresse selon trois principes qui ont un fondement biologique et qui sont interreliés : l'organisation cognitive, l'adaptation et l'équilibration. Piaget a nommé ces principes des invariants fonctionnels, car ils agissent à tous les stades du développement cognitif. Pour Piaget, l'organisation cognitive désigne la tendance à créer des structures cognitives de plus en plus complexes appelées « schèmes ». Le schème constitue un modèle d'organisation de l'information qui permet à l'individu d'agir ou de penser dans une situation donnée. C'est une structure cognitive élémentaire qui se construit et évolue en fonction des nouvelles expériences faites par l'enfant. Par exemple, pour le nourrisson, le schème de succion repose au départ sur le réflexe inné de succion, puis intègre peu à peu toutes les façons de sucer que le bébé expérimente, que ce soit le biberon, son poing ou l'oreille de son ourson. Si les premiers schèmes sont sensoriels et moteurs, l'enfant construira par la suite des schèmes mentaux beaucoup plus complexes comme, par exemple, des façons de classer ou de comparer divers objets ou éléments. À chaque stade de son développement, l'enfant essaie de donner un sens à son univers et il y parvient en organisant systématiquement ses connaissances. À partir de structures organisationnelles simples, le développement cognitif évolue donc vers des structures de plus en plus complexes. Par exemple, les habiletés utilisées par un enfant pour regarder, saisir et agiter son hochet fonctionnent d'abord séparément. Par la suite, l'enfant organise ces habiletés distinctes en un seul schème, plus complexe, qui lui permet de regarder son ourson tout en le tenant et en l'agitant, donc de coordonner l'œil et la main.

L'adaptation terme que Piaget emploie pour désigner la façon dont une personne traite une nouvelle information à la lumière de ce qu'elle connaît déjà constitue le deuxième invariant fonctionnel. L'adaptation est rendue possible grâce à deux mécanismes complémentaires qui fonctionnent en interaction, soit l'assimilation de la nouvelle information et l'accommodation à celle-ci. L'assimilation consiste à incorporer une nouvelle information dans une structure cognitive existante. Par exemple, lorsque sa mère lui donne un nouveau jouet, Cédric le touche, le regarde, le porte à sa bouche. Il l'assimile alors aux schèmes de vision, de préhension et de succion qu'il possède déjà. Quant à l'accommodation, elle consiste à modifier une structure cognitive existante pour tenir compte d'une nouvelle information ou situation. Ainsi, l'enfant qui commence à manger à la cuillère doit modifier son schème de préhension : s'il veut que la nourriture arrive à sa bouche, il ne peut pas tenir sa cuillère comme il tient son ourson ; il est obligé de développer une nouvelle façon de la tenir et, ce faisant, il s'adapte. L'assimilation et l'accommodation fonctionnent de pair et en interaction constante pour permettre une adaptation toujours meilleure aux conditions changeantes de l'environnement.

L'équilibration représente le troisième invariant fonctionnel. Piaget emploie ce terme pour désigner la tendance à rechercher un état d'équilibre entre les divers éléments cognitifs. Il peut s'agir d'un équilibre entre les différents éléments cognitifs ou entre la personne et le monde extérieur. Par exemple, un enfant qui sait ce qu'est un oiseau voit un avion pour la première fois. Il montre l'avion et l'appelle « oiseau » (assimilation). Cependant, peu à peu, il observe

des différences entre les oiseaux et les avions (comme battre ou non des ailes, par exemple), ce qui crée un déséquilibre cognitif et l'amène à modifier sa représentation de l'oiseau (assimilation) et à adopter un nouveau mot pour désigner un « avion » (équilibre). C'est ce besoin d'équilibre qui amène l'enfant à passer de l'assimilation à l'accommodation et réciproquement. En effet, lorsque ses structures cognitives existantes s'avèrent insuffisantes pour affronter une nouvelle situation, il doit en développer de nouvelles pour retrouver l'équilibre et s'adapter. Au cours de la vie, la recherche d'équilibre est une force qui sous-tend tout le développement cognitif.

Ce qui va être important pour l'explication en psychologie et pour la compréhension du développement mental soit l'acquisition des opérations cognitives chez l'enfant ce n'est pas tant l'équilibre en tant qu'état mais le processus même d'intelligence.

Les stades de développement : du nourrisson à l'adolescent

Piaget propose de découper le développement de l'intelligence en quatre stades du développement :

- L'intelligence sensori-motrice
- L'intelligence préopératoire
- L'intelligence opératoire concrète
- L'intelligence des opérations formelles.

a) LE STADE SENSORI-MOTEUR (0 - 2 ANS)

Ce stade fait référence à une intelligence sans représentation, sans langage, sans concept. Cette intelligence est essentiellement pratique et s'appuie sur la perception et sur les schèmes moteurs dont l'enfant dispose.

Pendant cette période sensori-motrice, l'enfant commencera à mettre en relation les objets et les actes. Progressivement, il distinguera les moyens des fins et se rendra compte des résultats qu'il obtient.

Les réactions circulaires primaires se complexifient. L'enfant accède peu à peu à un univers d'objets permanents. Il passe de l'individualisme narcissique au choix objectal et passe des émotions primaires à des sentiments différenciés et durables.

b) LE STADE PRE-OPERATOIRE (2 - 7 ANS)

Cette période se distingue de la précédente par l'accès à la représentation. Piaget forme l'hypothèse qu'apparaît et se développe au cours de la seconde année une fonction qui permet l'évocation d'objets ou de situation non directement perceptibles : **la fonction symbolique**. Cette fonction se manifeste par la possibilité de conduites nouvelles : *l'imitation différée, l'image mentale, le jeu symbolique, le langage et le dessin*.

La fonction symbolique permet à l'intelligence de se détacher de l'action. Pendant cette période, la pensée de l'enfant est marquée par l'égoïsme, c'est-à-dire, le fait que l'enfant pense, voit et analyse les choses selon son propre point de vue et à l'aune de ce qu'il comprend de lui-même. Sa pensée est intuitive et se fonde sur sa perception.

c) LE STADE DES OPERATIONS CONCRETES (7 - 12 ANS)

Pendant cette période, il y a acquisition de la réversibilité de la pensée. L'enfant est capable d'annuler en pensée une opération ou une modification qu'il a pratiquée pour revenir à l'état initial. Il ne fonde plus sa pensée sur les seules données de sa perception.

C'est au cours de ce stade que l'enfant acquiert la notion de conservation physique de la substance, du poids et du volume ; conservations spatiales et numériques (*c'est seulement au cours de cette période qu'il accède au concept du nombre*). Selon Piaget, la conservation est une condition indispensable à toutes activités rationnelles. L'enfant devient capable d'effectuer des classifications, des sériations (opérations concrètes).

C'est aussi au cours de ce stade que l'enfant acquiert les notions de causalité, comprend les invariants du réel. Il devient capable de coopération. La camaraderie se développe, les jeux se déroulent en s'appuyant sur des règles valables pour tous. Le sentiment de justice morale et l'autonomie se développent.

d) LE STADE DES OPERATIONS FORMELLES (12 - 16 ANS)

C'est vers 11 – 12 ans que l'enfant se libère du concret et mène des raisonnements sur le possible et non plus seulement sur des manipulations d'objets concrets comme il le faisait précédemment. Les notions de nombre, de volume de poids, les structures logiques (classification et sériation) sont acquises. La pensée formelle, qui se construit à ce stade permet l'établissement de relations entre la réalité et la possibilité. Dernier stade de la pensée, c'est pour Piaget le moment où l'intelligence acquiert sa pleine maturité.

On voit apparaître au cours de ce stade, la pensée formelle et le raisonnement *hypothético-déductif*. La pensée formelle est celle qui s'appuie sur un matériel symbolique, un système de signes conventionnels tels que : *le langage, le symbolisme mathématique*. Le raisonnement hypothético – déductif quant à lui consiste à tirer des conclusions directement des hypothèses sans avoir nécessairement besoin de passer par l'observation réelle et concrète.

En somme, on peut dire qu'il semble important de replacer la théorie piagétienne du développement cognitif dans le cadre plus général du constructivisme, théorie de l'apprentissage développée par lui dès 1923, en réaction au behaviorisme qui, d'après lui, limitait trop l'apprentissage à l'association stimulus-réponse. L'approche constructiviste met en avant l'activité et la capacité inhérentes à chaque sujet, ce qui lui permet d'appréhender la réalité qui l'entoure.

Le constructivisme suppose que les connaissances de chaque sujet ne sont pas une simple « copie » de la réalité, mais une « (ré) construction » de celle-ci. Le constructivisme s'attache à étudier les mécanismes et processus permettant la construction de la réalité chez les sujets à partir d'éléments déjà intégrés.

L'apport de Piaget aura des incidences profondes sur l'épistémologie, en tant que théorie générale de la connaissance, mais aussi sur des thèmes qui l'inspireront plus tard et sur lesquels il écrira d'ailleurs des ouvrages considérés aujourd'hui comme des classiques. L'œuvre de Piaget est diffusée dans le monde entier et continue à inspirer aujourd'hui encore, des travaux dans des domaines aussi variés que la psychologie, la sociologie, l'éducation, l'épistémologie, l'économie et le droit, comme en témoignent les Catalogues annuels publiés par la Fondation Archives Jean Piaget.

B. LE DEVELOPPEMENT AFFECTIF

L'affectivité semble être la base ou le fondement de la vie psychique, c'est grâce à l'affectivité que l'enfant commence à se situer dans le monde, qu'il déterminera aussi ses relations avec autrui.

C'est en effet l'affectivité qui fonde la personnalité de l'individu. De même, l'être humain a besoin pour que soit développée son intelligence, de se sentir protégé et aimé.

L'affectivité est une disposition psychique par laquelle un individu peut éprouver des sentiments de plaisir et de douleur. Elle est conçue comme une capacité individuelle à éprouver des sentiments et des émotions. Elle peut aussi être conçue comme une réaction émotive globale pouvant avoir des effets sur le corps et sur l'esprit.

L'affection quant à elle renvoie à la disposition d'un individu qui éprouve des sentiments à l'égard de lui-même et à l'égard des autres individus.

1. Les concepts clés de la théorie freudienne

- **Pulsion** : La pulsion désigne « les tendances dynamiques inconscientes de la personnalité qui agissant d'une façon permanente, orientent la conduite de l'individu vers leur satisfaction » (Sillamy, 1996 :565). C'est une poussée exercée par le somatique qui s'impose à l'appareil psychique. La pulsion a une source somatopsychique, un but qui est la satisfaction pulsionnelle, et un objet par lequel cette satisfaction est atteinte.

- **Libido** : Énergie motrice des pulsions de vie. C'est la manifestation dynamique, dans la vie psychique, de la pulsion sexuelle. La libido peut se diriger vers des personnes ou des objets extérieurs, se retourner sur le corps propre, ou alimenter les activités intellectuelles. Au cours de la croissance de l'enfant, elle va se localiser sur diverses zones érogènes.

- **Zone érogène** : Zone du corps susceptible d'être le siège de la satisfaction pulsionnelle. Elle va changer tout au long du développement de l'enfant.

- **Fixation** : Au cours du développement, l'énergie motrice qu'est la libido est investie dans des zones érogènes différentes et appelle à des formes de satisfactions données. Lorsque, passé un stade, l'individu recherche encore des moyens de satisfactions qui lui sont liés (à ce stade dépassé), Freud parle de fixation.

La fixation peut donc être définie comme la recherche constante d'une forme de satisfaction liée à un stade de développement dépassé. Elle résulte d'un trop-plein d'énergie donc la satisfaction a été frustrée, ou au contraire, à un plaisir lié à une trop grande satisfaction.

- **Régression** : La régression désigne le retour à une forme de comportement caractéristique d'un stade dans lequel l'individu a fait une fixation, à la suite d'une situation que l'individu n'arrive pas à gérer.

2. Les stades de développement affectif

Freud a donné une description chronologique du développement affectif. Toutefois, aucun stade n'est purement et simplement dépassé, il y a juste un déplacement de l'investissement libidinal d'une zone érogène à une autre.

➤ Le stade oral (0- 1an)

La zone érogène prévalente est la zone bucco-faciale-pharyngienne, les tubes digestif et respiratoire et les organes sensoriels. Il s'agit ici de s'approprier des éléments de

l'environnement. L'objet pulsionnel est le sein ou son substitut, le but pulsionnel est un plaisir autoérotique et un désir d'incorporation d'objet.

K. Abraham subdivise ce stade en deux : le stade oral primitif caractérise par une absorption passive ; et le stade oral tardif qui apparaît en même temps que la poussée dentaire, et qui se caractérise par une activité de morsure.

Le sevrage est le conflit relationnel spécifique de cette période. S'il est trop précoce, c'est-à-dire avant que l'investissement libidinal n'ait pu se déplacer sur d'autres objets, l'enfant peut se fixer à une relation de type oral passif. Si par contre il survient au cours de la période de morsure, l'enfant peut le ressentir comme une punition.

Bien que la notion d'objet soit encore prématurée, on observe un début de relation objectal dans les interrelations précoces de l'enfant avec sa mère. Dans ces premières relations objectales, le nourrisson n'a pas encore conscience du dehors ni du dedans, du soi et du non-moi. Il en prend progressivement conscience dans des expériences de manque dans lesquelles la tension est interne et la satisfaction externe. Toutefois, la tension étant abaissée, il ne reste plus de conscience d'un objet extérieur.

➤ **Le stade anal (1-3ans)**

La zone érogène est composée de la vessie et des sphincters. Il s'agit, soit de conserver les objets passés à l'intérieur de soi, soit de les expulser après destruction. L'objet pulsionnel est la mère et l'entourage en général, qu'il faut maîtriser et manipuler. Le but pulsionnel est d'une part un plaisir autoérotique par la stimulation de la zone anale, d'autre part une recherche de pression relationnelle sur les objets et les personnes.

Comme le précédent, ce stade est divisé en deux : la phase sadique anale expulsive caractérisée par l'expulsion intempestive de selles ; et la phase masochique anale rétentive caractérisée par la recherche d'un plaisir passif lié à la rétention des matières fécales.

Le conflit majeur à ce stade est l'acquisition de la propreté, l'enfant doit apprendre à contrôler ses besoins. L'objet fécal peut, selon le temps et le lieu d'expulsion ou de rétention, servir d'arme ou de cadeau. L'éducation sphinctérienne ne doit être ni trop précoce, ni trop rigide, afin que l'enfant ait le temps d'éprouver un pouvoir sur l'autre.

Sur le plan de l'objet, la frontière entre l'intérieur et l'extérieur se consolide et l'enfant commence à prendre plaisir à la manipulation d'objets extérieurs.

➤ **Le stade phallique (3-7ans)**

Il est centré autour de la thématique de la présence ou de l'absence du pénis, mais on ne peut pas encore parler de généralisation de la libido.

La zone érogène est l'urètre, avec un double plaisir de miction et de rétention. Le plaisir urétral comporte une dimension autoérotique et une dimension objectale (fantasme d'uriner sur autrui).

À ce stade, l'enfant découvre la différence des sexes, c'est-à-dire la présence ou l'absence du pénis. Le stade phallique devient alors un déni de cette différence manifeste chez le garçon par la négation du sexe féminin, ou la croyance en une mère pourvue du pénis. Chez la fille, il se manifeste par la croyance en une poussée ultérieure du clitoris ou par des comportements brutaux, la recherche du danger, les allures de garçon manqué.

Ce stade est également marqué par l'exhibitionnisme et la masturbation.

Sur le plan objectal, le pénis est conçu comme un organe porteur de puissance, et non comme un organe génital. En outre, c'est un objet partiel, détachable fantasmatiquement.

Au cours de ce stade se pose la problématique du complexe d'Œdipe

❖ **Le complexe d'Œdipe (4-7ans)**

Il structure le groupe familial et la société. C'est le moment de la vie psychique assurant le primat de la zone génitale, le dépassement de l'autoérotisme et l'orientation vers les objets extérieurs.

Le complexe d'Œdipe correspond à une attirance pour le parent de sexe opposé et à des sentiments de haine et de rivalité à l'égard du parent de même sexe. Il est différent selon qu'on soit chez le garçon ou chez la fille.

Chez le garçon, le complexe d'Œdipe ne suppose pas le changement d'objet d'amour, la mère étant l'objet d'amour initial ; chez la fille, un tel changement doit se produire. De plus, chez le garçon, l'angoisse de castration vient mettre un terme à la problématique œdipienne, alors qu'elle permet l'entrée dans cette problématique chez la fille. Le complexe d'Œdipe se résout par l'intériorisation des valeurs morales et l'identification au parent de même sexe.

Le complexe d'Œdipe permet l'identification, car il instaure une prévalence de l'être sûr l'avoir. Ainsi, il ne s'agit plus seulement d'avoir le pénis, mais d'être homme ou femme.

Enfin, le complexe d'Œdipe permet la mise en place du surmoi et de l'idéal du Moi par l'intériorisation des interdits parentaux.

➤ **La période de latence (7- à la puberté)**

Les zones érogènes sont désinvesties, et il y a une modification structurale des pulsions sexuelles. Ceci fait de la période de latence une période théoriquement conflictuelle bien que les conflits des stades précédents y soient toujours vécus dans une faible intensité.

C'est l'époque où les enfants entrent à l'école et sont plus préoccupés par les relations entre pairs, les loisirs et autres intérêts non libidinaux. La période de latence est un temps d'exploration dans lequel l'énergie sexuelle est toujours présente, mais elle est dirigée vers d'autres domaines tels que la recherche intellectuelle et les interactions sociales.

➤ **Le stade génital (puberté – 18/21ans)**

L'adolescence vient clore la période de latence. Elle est entrée sur une crise narcissique et identificatoire, avec des angoisses quant à l'intégrité de soi, du corps et du sexe.

Avec les modifications sexuelles, on assiste à des émergences pulsionnelles massives qui viennent déséquilibrer les rapports entre les instances intrapsychiques. On retrouve ici une restructuration de la problématique œdipienne, avec déplacement sur des substituts parentaux (enseignants, artistes...) On retrouve également une réactivation des problématiques prégénitales, et on observe une tendance au passage à l'acte.

Enfin c'est une période de renoncements multiples : renoncement aux illusions personnelles, à l'idéal du Moi qu'on s'est fait, et renoncement aux images parentales car on se rend compte de leur imperfection. A la fin de l'adolescence, s'opère le choix définitif de l'objet sexuel.

**TABLEAU RECAPITULATIF DES STADES PSYCHOSEXUELS DU
DEVELOPPEMENT**

STADES	AGES (AN)	ZONES EROGENES	TACHES MAJEURES DU DEVELOPPEMENT	FIXATION A STADE
Stade oral	0 à 1	Bouches, lèvres, langue	Sevrage	Comportement oral, fumer; trop manger; sarcasme
Stade anal	1 à 3	Anus	Apprentissage de la propreté	Ordre, parcimonie, obstination ou l'inverse
Stade phallique	3 à 5	Parties génitales	Complexe d'Oedipe	Vanité, insouciance et l'inverse
Stade de latence	5 à 12	Aucune zone particulière	Développement des mécanismes de défense	Aucune fixation ne survient à ce stade habituellement
Stade génital	13 à 18	Parties génitales	Maturité de l'intimité sexuelle	Si les stades précédents ont été intégrés, les adultes sont équilibrés

C – Développement socio-émotionnel des nourrissons aux carences affectives

L'une des premières théories qui a souligné l'importance du développement affectif du bébé et le lien entre ce développement affectif et l'exploration est la théorie de l'attachement de Bowlby développée en 1958. Cependant, cette théorie a été critiquée par la communauté scientifique car très peu basée sur des travaux empiriques mais seulement sur l'observation d'enfants séparés de leur mère dans le cas d'hospitalisation. C'est grâce aux observations méthodiques de Trevarthen (1984) quelques années plus tard que la dimension affective de l'interaction mère- bébé a été pleinement prise en compte. Trevarthen décrit à travers l'observation d'expressions faciales de 6 000 clichés de bébés filmés en interaction le développement de leurs expressions émotionnelles durant les quelques premiers mois de leur vie. Il montre que :

- dès 4-6 semaines de vie, les bébés sourient lorsqu'ils fixent le regard de leur mère et peuvent montrer des expressions d'inconfort et de colère ;
- à 6 semaines, ils peuvent montrer du plaisir face à la mère et de la gêne face à un étranger ;
- à 2-3 mois, les expressions émotionnelles deviennent plus élaborées et contingentes à celles de la mère ;
- à 3 mois, les bébés commencent à s'intéresser aux objets et rient dans des situations de jeu avec la mère ;
- à 3-4 mois, on observe des expressions de méfiance et de peur ;
- à 5-6 mois, les bébés apprécient les jeux de surprise (jeu du coucou) et on observe une augmentation des réactions de peur.

Ainsi, la compréhension des émotions et l'utilisation des expressions émotionnelles pour réguler les interactions sont observables durant les premières semaines de vie. Les

émotions se développent en relation dyadique pendant les deux premiers mois de vie et ensuite en relation à l'objet dès le 3^e mois. La relation à l'étranger est d'abord positive puis devient de plus en plus négative. Enfin, le jeu est un moyen privilégié de communication émotionnelle entre la mère et le bébé dès le 5^e mois de vie. Nous reviendrons sur cette notion de jeu et d'humour dans le paragraphe suivant. En plus de ces observations méthodiques, d'autres études empiriques ont également montré la présence des émotions très tôt dans la vie. En effet, les bébés reconnaissent et catégorisent les émotions dès les premiers mois de vie (5 mois : Caron et al, 1988 ; Schwartz et al, 1985 ; 10 semaines : Haviland & Lelwica, 1987). À 4 et 6 mois, les bébés préfèrent regarder des visages joyeux comparés à des visages exprimant la colère ou des visages neutres (Kestenbaum & Nelson, 1990 ; LaBarbera et al, 1976). À 4 mois, les bébés préfèrent regarder des visages exprimant la colère avec contact visuel comparés à des visages exprimant la colère mais dont le regard est détourné (Striano et al, 2006). À 7 mois, les bébés préfèrent écouter des stimuli auditifs prononcés avec joie ou colère comparés à des stimuli neutres et à l'aide de l'EEG, nous savons que les mots prononcés avec colère rehaussent davantage l'attention comparés aux mots prononcés avec joie ou aux mots neutres (Grossmann et al, 2005).

D'un point de vue intégratif, les émotions ont un impact important sur le développement cognitif. Nous connaissons par exemple le lien entre la motivation d'explorer cognitivement le monde et la qualité de l'attachement (Ainsworth, 1973 ; Ainsworth & Witting, 1969). Nous savons grâce aux travaux d'Eléonor Gibson et la célèbre étude de la falaise visuelle que les bébés n'explorent pas le côté profond si leur mère exprime des émotions négatives (Gibson et Walk, 1960). Par ailleurs, une étude récente a montré que les bébés sont d'avantage influencés par les émotions négatives que positives (Vaish, Grossmann et Woodward, 2008). D'autres études ont montré que non seulement l'exploration de l'environnement est affectée par les émotions mais également l'exploration d'objets (Mumme et Fernald, 2003). Ainsi les émotions jouent un rôle important dans le développement social et cognitif des bébés et ne peuvent être négligées lors de la prise en charge d'un bébé et de sa famille.

C'est à Bowlby (1969) que l'on doit la théorie de l'attachement, qui a influencé considérablement la psychologie du développement. L'attachement se définit comme le lien affectif, durable et réciproque entre un enfant et la personne qui en prend soin. L'attachement a une fonction adaptative pour l'enfant. Il lui assure le bien-être physique et affectif dont ce dernier a besoin. Ce lien d'attachement développé durant la petite enfance semble être déterminant pour l'établissement et la qualité des liens interpersonnels futurs chez l'individu. Avant d'examiner davantage la théorie de l'attachement et ses implications, nous poserons un regard plus large quant aux différentes perspectives théoriques sur l'émergence de la relation parent-enfant et nous verrons les études en éthologie sur la relation parent-enfant qui ont inspiré Bowlby.

S'appuyant sur la notion de période critique (ou sensible), la théorie de Bowlby suggère que les carences dans l'établissement du lien d'attachement sont irréversibles si elles interviennent au premier âge (Bowlby, 1969). Pour Bowlby, l'attachement est un lien affectif positif qui s'accompagne d'un sentiment de sécurité et qui ne peut être observé directement. Ce que l'on peut observer, ce sont des comportements d'attachement visant la proximité tels que des regards, des sourires, des contacts, des pleurs.

De tels comportements apparaissent surtout lorsque l'enfant a besoin d'être soigné, réconforté ou sécurisé, c'est-à-dire lorsqu'il veut maintenir le contact ou se rapprocher de sa figure d'attachement. En plus des comportements visant la proximité, Bowlby décrit un second type de comportement qui vise l'exploration et dont la fonction est de favoriser l'adaptation à l'environnement.

1- Les phases du développement de la relation d'attachement

La création du lien d'attachement entre un enfant et la personne qui répond à ses besoins au quotidien est un processus qui se déroule lentement au cours des deux premières années de vie de l'enfant. L'attachement s'établirait en trois phases : le pré attachement, l'émergence de l'attachement et l'attachement véritable (Ainsworth, 1989 ; Bowlby, 1969).

Avant l'âge de deux ou trois mois, l'enfant manifeste un ensemble de comportements d'attachement innés (pleurs, agrippements, sourires, etc.), mais ils ne sont pas différenciés en fonction des personnes qui prennent soin de lui : on parle alors **de pré-attachement**.

Dès la huitième semaine, le bébé se met à orienter ses comportements d'attachement vers les personnes proches de lui, et plus particulièrement sa mère : **c'est l'émergence de l'attachement**. Ses avances portent des fruits quand la mère répond chaleureusement et avec plaisir, lui offrant de fréquents contacts physiques et la liberté d'explorer. Le bébé acquiert ainsi des sentiments d'emprise sur le monde et de confiance en lui, lié à sa capacité d'obtenir des résultats. Toutefois, il n'est pas encore véritablement attaché à elle.

En effet, **l'attachement véritable** n'apparaîtrait pas avant six ou huit mois : une personne, généralement la mère, devient alors la figure d'attachement principale. C'est au cours de cette dernière phase de création du lien d'attachement que se manifestent la peur de l'étranger et l'anxiété de séparation.

Selon Bowlby (1969), l'enfant est actif dans la création d'un lien d'attachement. Pour ce faire, il se construit un modèle opérationnel interne (MOI), c'est-à-dire une représentation des comportements et des attitudes de sa figure d'attachement, généralement sa mère. Ce modèle demeure stable sauf si la mère modifie de façon importante sa manière d'agir avec l'enfant.

2- Les formes d'attachement

Ainsworth décrit trois formes d'attachement : un attachement sécurisant (la forme la plus courante, chez 66 % des bébés) et deux formes d'attachement insécurisant, soit l'attachement insécurisant de type évitant (chez 20 % des bébés) et l'attachement insécurisant de type ambivalent (chez 12 % des bébés), ces deux dernières formes étant anxiogènes (Ainsworth et al., 1978, 2015).

- **L'attachement sécurisant** est la forme d'attachement dans laquelle l'enfant manifeste de la confiance en présence de sa mère, de la détresse en son absence et un retour à la confiance au moment de la réunion avec la mère.
- **L'attachement insécurisant de type évitant** est une forme d'attachement perturbé, dans laquelle l'enfant manifeste une distance à l'égard de sa mère lorsqu'elle est

présente, une indifférence au moment de son départ, et une absence de réconfort à son retour.

- **L'attachement insécurisant de type ambivalent** est une forme d'attachement perturbé, dans laquelle l'enfant affiche une anxiété en présence et en l'absence de sa mère. Au moment de la réunion avec cette dernière, l'enfant démontre tout à la fois une recherche de réconfort et des comportements de rejet et de résistance envers la mère.

3- Les conséquences à long terme de l'attachement

Comme la théorie de l'attachement le prédit, ce lien affectif influe sur les compétences émotionnelles, cognitives et sociales d'un individu (Van Ijzendoorn et Sagi, 1999). Ainsi, plus l'enfant est attaché de façon sécurisante à l'adulte qui s'occupe de lui, plus il lui sera facile de s'en éloigner pour explorer son environnement, ce qui l'expose à une diversité d'expériences et à autant d'occasions d'apprendre. C'est aussi cette capacité d'exploration qui lui permet d'entrer en contact avec plus de personnes et de développer ainsi des habiletés sociales. Globalement, les enfants attachés de façon sécurisante entretiennent aussi une attitude plus positive à l'égard de l'inconnu.

L'attachement sécurisant semble donc préparer l'enfant à l'intimité des relations amicales (Carlson, Sroufe et Egeland, 2004). Cela est également vrai plus tard pour les relations amoureuses. En effet, un attachement sécurisant durant l'enfance semble influencer la qualité de l'attachement du jeune adulte à son partenaire amoureux (Simpson et al., 2007).

En outre, on a aussi montré que les enfants qui vivent un attachement sécurisant possèdent un vocabulaire plus varié que ceux dont l'attachement est insécurisant (Meins, 1998). De trois à cinq ans, ils se montrent plus curieux, plus compétents, plus empathiques et plus confiants en eux-mêmes (Elicker, Englund et Sroufe, 1992). Ils ont non seulement une meilleure estime de soi, mais ils manifestent également moins de comportements agressifs et font preuve de persévérance dans l'exécution d'une tâche (Cloutier, Gosselin et Tap, 2005). À l'âge scolaire et à l'adolescence, les enfants qui ont développé un attachement sécurisant tendent à avoir les relations d'amitié les plus étroites et les plus stables, du moins dans les pays occidentaux où ont été réalisées la plupart des recherches (Schneider, Atkinson et Tardif, 2001), et à être mieux adaptés socialement (Jaffari-Bimmel et al., 2006).

De leur côté, les enfants qui ont développé un attachement insécurisant connaissent plus souvent des problèmes à long terme : ils sont inhibés, éprouvent davantage d'émotions négatives, se montrent plus colériques ou agressifs. Ils sont plus hostiles envers d'autres enfants à l'âge de cinq ans et plus dépendants à l'âge scolaire (Kochanska, 2001 ; Sroufe, 1983). Quant aux enfants qui vivent un attachement désorganisé et désorienté, ils risquent davantage de présenter des problèmes de comportement à l'école et d'être atteints de troubles de santé mentale vers l'âge de 17 ans (Carlson, 1998).

D – LE DEVELOPPEMENT DES RELATIONS A L'ADOLESCENCE

Bien que l'influence familiale ne soit plus aussi importante que pendant l'enfance, la famille joue encore un rôle primordial à l'adolescence. C'est en son sein que se sont transmis pendant l'enfance, et se transmettent encore en partie lors de l'adolescence, bon nombre de règles et de modèles, tant par inculcation des modes de penser, de sentir et d'agir, que par

intériorisation inconsciente à travers l'imitation de ces agents socialisateurs privilégiés (Galland, 1991).

➤ **Les relations avec les parents**

Les rapports familiaux sont le prototype des relations ultérieures. Il n'en est pas moins vrai qu'un dépassement social de la famille s'avère nécessaire à l'adolescence. Ce dépassement peut parfois constituer une expérience pénible conduisant au conflit ouvert, mais se traduit beaucoup plus souvent par une expérience positive d'accession consentie et graduelle à une autonomie sociale personnelle. Réciprocité et coopération tendent à se substituer dans la relation parents/adolescents à l'autorité unilatérale qui caractérisait leurs rapports pendant l'enfance. À l'adolescence, le jeune prend conscience des limites de ses parents, parallèlement à la découverte de ses propres limites. Une bonne communication au sein de la famille nécessite alors qu'il y ait compréhension réciproque (Cloutier, 1996). Dans l'ensemble, les jeunes restent d'ailleurs assez bien intégrés au sein de la famille si l'on se réfère à l'enquête nationale réalisée par Choquet et Ledoux (1994). Pour sept adolescents sur dix, la vie familiale est agréablement vécue. Elle s'avère plutôt détendue et généralement recherchée : 71 % des jeunes perçoivent l'intérêt de leur père et 67 % celui de leur mère. L'ambiance familiale apparaît cependant plus positive pour les garçons (74 %) que pour les filles (67 %). La famille apparaît ainsi pour de nombreux jeunes, garçons et filles, comme étant un lieu d'échanges et de discussion. Les relations au sein de la famille se modifient peu au cours de l'adolescence sauf en ce qui concerne les sorties avec les parents qui diminuent entre 11 et 18 ans. De même, les parents s'avèrent de moins en moins des interlocuteurs privilégiés lorsque les adolescents grandissent, quel que soit le domaine.

➤ **Les relations au sein de la fratrie**

L'existence de rivalités fraternelles au sein d'une famille est d'observation courante et il est normal qu'entre frères (et sœurs) existe un certain degré d'agressivité tempérée par des sentiments mutuels d'affection. Les relations fraternelles comportent cependant nettement plus d'aspects positifs que d'aspects négatifs à l'adolescence. En effet, frères et sœurs semblent s'apporter du réconfort et un soutien moral, et avoir des activités communes, ce qui n'empêche pas les disputes. La coopération et l'entraide restent les caractéristiques dominantes des relations fraternelles. Frères et sœurs accèdent enfin à une relative individualité au sein de la famille, en particulier à travers l'expérience qu'ils ont de leurs parents, mais aussi au regard des groupes amicaux auxquels ils participent. Certains travaux ont mis l'accent sur le rôle de l'aîné comme agent de socialisation (Abramovitch et al, 1982). Il existe également des effets en fonction de la dimension sexuée de la fratrie, du rang de naissance et de l'écart d'âge. Il existe par exemple un grand sentiment de proximité lorsque la fratrie est unisexuée avec un écart d'âge faible, que ce soit pour les comportements prosociaux, éducatifs, d'intimité ou de compagnonnage.

➤ **Les relations amicales à l'adolescence**

La plupart des adolescents s'intéressent aux autres jeunes. L'adolescence ouvre aussi une ère nouvelle de sociabilité : celle de l'amitié. Pour se trouver lui-même, l'adolescent cherche de nouveaux modèles chez ses pairs. Il est souvent persuadé que ses parents ne le comprennent pas, ne peuvent le comprendre dans sa singularité ; il se sent malheureux et

désinvesti de leur amour, projetant ses propres sentiments et subissant également un éventuel retour de sa propre agressivité. Ses nouvelles activités hors du champ familial, ses nouvelles rencontres, ses multiples et interminables discussions sont propices à la création de relations amicales. L'amitié permet à l'adolescent de se reconstruire, de se restructurer après les bouleversements qu'il a subis. Les amis, avec leur qualité d'écoute, leur présence, leur compréhension et leur disponibilité, vont apporter au jeune l'étayage qu'il ne trouve plus chez ses parents. L'amitié est un sentiment réciproque d'affection et de sympathie. Elle implique une nécessaire complémentarité entre deux personnes mais aussi une certaine ressemblance. L'adolescent cherche alors un double de lui-même, un alter ego qui participera à la réussite de cette quête identitaire qui se fait en soi-même et en autrui (Rodriguez- Tomé, 1972). Les amitiés adolescentes possèdent un certain nombre de caractéristiques particulières : l'intimité, la sensibilité, le degré de similitude ou de complémentarité et la stabilité (Berndt, 1982 ; Mallet, 1997). L'intimité, c'est la connaissance profonde de l'autre (sa personnalité, ses inquiétudes, ses angoisses, ce qui fait sa vie). Les amis adolescents renforcent leur estime de soi à travers ce que leur renvoie l'autre.

➤ **Les relations amoureuses à l'adolescence**

La vie amoureuse des adolescents s'inscrit dans le contexte global de leur quête identitaire. L'amour préoccupe tous les jeunes, garçons et filles. Comme le remarque Claes (2003), les amours adolescentes sont le lieu d'émergence d'émotions nouvelles, les affects liés à ces relations constituant une part essentielle de la vie émotionnelle des jeunes. Ces relations, qui sont sources d'émotions et d'expériences intenses, peuvent également provoquer des sentiments de détresse, de souffrance, de jalousie et de désespoir. Après la puberté, les pulsions sexuelles conduisent l'adolescent à rechercher un partenaire, généralement du sexe opposé, qui devient sa figure d'attachement centrale, prenant la place du parent désinvesti, mais il y a de grandes similitudes entre les liens unissant un couple et ceux qui reliaient le bébé à sa mère, tant en ce qui concerne la proximité du contact corporel, l'affection exprimée par des baisers et des caresses, l'attention mutuelle aux besoins de l'autre, que la capacité partagée de répondre adéquatement à ces besoins. Il existe toutefois quelques différences essentielles : alors que les relations unissant les parents et l'enfant sont asymétriques, les rapports amoureux sont symétriques et réciproques, chacun servant de figure centrale d'attachement à l'autre. En outre, le désir sexuel a un rôle primordial dans le choix du partenaire amoureux et la sexualité entretient la force du lien.

➤ **La scolarité à l'adolescence**

Dès l'entrée au collège, l'enfant devient capable d'abstractions et, comme le montre Piaget (1955), accède à la pensée formelle, hypothético- déductive. Cet accès à l'abstraction n'est pas toujours facile, et les difficultés peuvent entraîner un manque d'attention, voire un manque d'intérêt pour l'école. Du point de vue psychomoteur, l'intensité des transformations corporelles entraîne une évolution du schéma corporel et de l'image du corps et un bouleversement de la représentation de l'espace et du contrôle tonicomoteur qui retentit sur la scolarité tant en ce qui concerne l'exécution des tâches (écriture, travaux manuels, appropriation de l'espace), que leur compréhension. Le désir d'autonomie et d'indépendance par rapport à la famille facilite l'exploration de champs d'intérêt personnels et l'identification à un auteur, à une

idéologie, voire à une discipline par l'intermédiaire d'un enseignant. Certains jeunes réussissent leur adaptation au collège et obtiennent de bons résultats. D'autres rencontrent des difficultés plus ou moins marquées. L'échec scolaire implique en réalité la non- adéquation du niveau d'acquisitions d'un enfant par rapport aux objectifs définis par les programmes correspondant à son âge.

Absences, justifiées ou non, et retards, occasionnels ou exceptionnels, s'avèrent des comportements fréquents à l'adolescence. La régularité de ces conduites, bien que plus rare, ne s'en avère pas moins conséquente. Il y a ainsi chaque année des milliers de jeunes qui abandonnent leurs études sans avoir terminé le cycle engagé, parfois même alors qu'ils n'ont pas atteint cet âge de 16 ans qui marque la fin de l'instruction obligatoire. Chercher à mieux comprendre les processus de décrochage scolaire peut se faire en prenant deux points de vue différents mais complémentaires en termes d'explication (Coslin, 2017). Le premier s'intéresse à la genèse de l'échec scolaire et au processus conduisant de cet échec à la déscolarisation. Le second point de vue considère la déscolarisation comme résultant d'une conjonction de facteurs. Il faut alors prendre en compte les principaux éléments de l'histoire familiale de ces jeunes, leur éventuelle trajectoire migratoire, leur histoire scolaire et les caractéristiques de leur sociabilité enfantine et adolescente, à l'école et en dehors de l'école. Comme le rappelle Huteau (1995), les intentions d'avenir exprimées par les adolescents diffèrent sensiblement selon que l'on s'adresse à des garçons ou à des filles. Ainsi, dans les baccalauréats de l'enseignement général, 45 % des jeunes inscrits dans la filière D sont des filles alors qu'elles sont 65 % dans la filière ESF et 82 % dans la filière A. De même, en ce qui concerne les métiers choisis, les professions d'électricien, de mécanicien, d'ingénieur ou d'informaticien sont typiquement masculines, tandis que d'autres s'avèrent féminines : secrétaire, professeur d'école, comptable, etc.

➤ Les principaux troubles du comportement à l'adolescence

Plusieurs questions majeures de santé publique concernent de près la population adolescente :

- Interruptions de scolarisation très préjudiciables à cet âge,
- Tentatives de suicide et, dans une moindre fréquence, suicides aboutis ;
- Consommations de produits illicites ;
- Prises de risque avec leurs conséquences en termes d'accidents de circulation surtout ;
- Tout ce qui touche à la violence, qu'elle soit subie ou agie.

La consommation de substances illicites commence généralement à l'adolescence et constitue souvent une situation à risque. Si tous les consommateurs ne répondent pas aux critères de la dépendance, le risque d'une dépendance aux produits à l'âge adulte est d'autant plus fort que la consommation a commencé pendant l'adolescence. Le risque de dépendance ultérieure diminue à mesure que le début de la consommation du sujet est plus tardif. Il y aurait donc un lien entre consommation abusive ou dépendance à l'âge adulte et début de consommation à l'adolescence : si tous les adolescents consommateurs ne deviennent pas toxicomanes, la grande majorité des adultes consommateurs abusifs ou toxicomanes ont débuté leur consommation abusive dès l'adolescence : plus on les repère tôt, mieux on peut espérer les soigner.

La mortalité par accidents représente presque la moitié (48.6 %) des causes décès chez les 15-24 ans et vient largement en tête de toutes les autres causes. La morbidité est très élevée, puisque 51 % des garçons et 36 % des filles déclarent avoir eu au moins un accident ; certes, il s'agit dans la majorité des cas d'un accident bénin, mais le taux de répétition est important. 28 % des jeunes ayant eu un accident présenteront une récurrence dans l'année suivante (8 % chez les non- accidentés). Parmi ceux qui ont plusieurs accidents, le taux de répétition est de 62 %. Les études de cas et les enquêtes prospectives montrent que les adolescents ayant eu un accident de circulation diffèrent déjà sensiblement des jeunes qui ont eu un accident de sport (situation heureusement la plus fréquente) et des jeunes tout venant, mais que cette différence est encore plus grande dans le cas de récurrences d'accidents (taux de dépression, d'anxiété significativement supérieur).